EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 86646
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-06-14 11:05:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: ENRIQUETA DEL CARMEN GAMONAL .			**RUN**	: 3.597.951-4
F.Nac	: 15-07-1935	**Edad**	: 88 AÑOS, 10 MESES	**Género**	: Femenino
Dirección	: ROBLE 18			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-06-09	**Fecha Egreso**	: 2024-06-14 11:05:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J81-EDEMA PULMONAR

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Insuficiencia Respiratoria aguda
-Bronconeumonia
ICC descompensada
EPA resuelto
Ant. Mórbidos: HTA, DM2, EPOC, obesidad mórbida

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J96.0-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente adulta mayor semidependiente, usuaria de silla de ruedas, HTA, ICC, EPOC, LCFA, DM, Poli artrosis, Obesidad, hospitalizaciones por por Edema pulmonar agudo, ultima 12/2021, tratamiento cronico Furosemida 20mg vo am Espironolactona 25mg vo am Aas 100mg am NPH 42UD am NPH 22UD pm Carvedilol 1comp pm (no recuerda dosis).
Ingresa desaturando en triage hasta 82%, agitada, desorientada, glw 4+4+5 : 13 pts. Hipertensa grave, febril, taquipneica grave hasta 40 rpm, cianosis distal. diaforesis, desorientada. Al ef. normocraneo, PIRRL, yugulares ingurgitadas, tórax simétrico hipo expandible, abdomen globuloso +++ a expensas de tejido adiposo, extremidades móviles con edema +++, insuficiencia venosa bilateral con piel descamada. ++. Se apoya con oxigeno 3 lt por naricera, con fio2 32 %. Se toman ex. GSA. Se inicia Bic de Nitroglicerina 60 gama/min, que se titula según requerimiento. Se administra tto depletivo y broncodilatador, con nebulizaciones con berudual. Se instala foley, n14. Se administra tto antipirético, paracetamol 1 gr mas 100 mg ketoprofeno, KNT para conexión a VMNI, por mala mecánica saturando 93% con 32 % FIO2, taquicardia sostenida aparente FA con RVR hasta 150 en monitor se administra tto antiarrítmico amiodarona 150 mg en bolo. Paciente tolera regularmente mascara full face de VMNI instalada por KNT.
solicitó RxTx que evidencia signos de congestión pulmonar, sin derrame pulmonar marcado ni focos de condensación, además EOC con signos inflamatorios por lo que se indició ceftriaxona 2 gr ev. Dentro de exámenes de ingreso destaca lactat0 3.2, DD 2365, GSA pH 7.44, pO2 86.3, pCO2 36.8, HCO3 25.1, FiO2 32%, PaFi 269, PCR 55, influenza A, B y VRS (-), crea 0.7
Se solicita evaluación por residente UTI y se constata paciente conectada a VNI, en GCS 15, cooperadora, con signos de ICC descompensada, por lo que se decide ingreso a unidad para continuar manejo medico donde estuvo por 2 dias con VMNI SOS; BD y KNT; FiO2 para sat 89-91% Monitorización invasiva, tratamiento depletivo para BH Inflamatorio: orina inflamatorio , UC negativo . Bronconeumonia en tto biasociado. manenter ATB , Panel viral negativo HCHM .

evulocionando stifactoriamnete por lo que se indica traslado ala servicio de Medicina, donde se logra destera de oxigeno por mas de 24 horas.
Al examen físico Yugulares planas, mucosas hidratadas, Eritema y aumento de volumen dedo medio derecho, Torax MP disminuido globalmente, crépitos bilaterales, RR2T soplo sistolico foco mitral 4/6, Abdomen globoso con importante tejido adiposo, RHA+, no se palpan masas ni visceromegalias, sin irritación peritoneal .EEII edema bilateral +, sin signos de TVP, pulsos presentes y simétricos. Neurológico GCS 15, sin focalida neurológica.
Exámenes control 13-6-24: pH : 7,48 pCO2 : 44,9 mmHg pO2 : 72,8 * mmHg HCO3 ACT. : 33,5 Creatinina : 0,80 mg/dl Calcio : 8,7 mg/dL Potasio (K) : 3,20 * mmol/ Cloro (Cl) : 101,00 leucocitos : 7,10 mil/ul Recuento Hematies : 4,54 Mill/ul Hematocrito : 40,0 o/o Hemoglobina : 13,7 Plaquetas : 291 Proteina C Reactiva : 25,1 Lactato : 1,1. En condiciones de alta medica con hodom .

PLAN DE MANEJO:

HD / CV: tratamiento depletivo
Ventilatorio: sin conflicto actual sat 89-91%
Inflamatorio: mantener ATB , Panel viral negativo HCHM
Renal: función renal conservada, sin trastorno HE asociado, evitar nefrotóxicos,
Metabólico: régimen hiposódico diabético
Se informa los signos de alarma, control sos urgencia (Disnea – Apremio Respiratorio)
Control poli Broncopulmonar
Control poli medicina

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo Relativo
2. Régimen: Hiposódico Para Diabético
3. Ceftriaxona 2 Gr/Día Ev (5/10)
4. Hidrocortisona 100 Mg C/12hrs Ev Por 5 Dias
5. Carvedilol 6,25 Mg Cada 12 Horas Vo
6. Furosemida 40mg Vo Am
7. Espironolactona 25mg Vo Am
8. Aas 100mg Am
9. Bromuro De Ipratropio 2 Puff C/6 Hrs Con Aerocamara
10. Salmeterol 2 Puff C/12 Hrs Con Aerocamara , Espironolactona 25 Mg 1/Dia
11. Nph 42ud Am Nph 22ud Pm
12. Rescatar Cultivos
13. Kine Respiratoria Y Motora

OBSERVACIONES:

Se informa a hijo las condiciones de la paciente y los signos de alarma.

Control en: 10 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

CARABALLO DE HURTADO
JENNIFER DEL CARMEN
MEDICO TRATANTE
26251544-3

JEFE SERVICIO